一般検査を契機に病理部連携で発見された皮膚原発 Hypomelanotic melanoma 胸膜転移症例

◎宇野 晃太郎[1)]、上野 嘉彦[1)]、加藤 洋平[1)]、石田 真理子[1)]、岡 有希[1)]、中川 篤[2)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院 検査部[1)]、岐阜大学医学部附属病院 病理部[2)]

【背景】悪性黒色腫はメラノサイト由来の悪性腫瘍であり，本邦における罹患率は 1.12 人/10 万人で希少がんに分類される。また，無色素ないし低色素性メラノーマ（Hypomelanotic melanoma）は，全メラノーマの 2-20%程度とされる。さらに，皮膚原発メラノーマの胸腔内転移および胸水貯留症例は報告があるものの，胸水一般検査での遭遇は稀である。今回，胸水一般検査を契機に病理部との連携から発見に至った皮膚原発低色素性メラノーマの一例を経験したので報告する。

【症例】70 代男性。20XX 年直腸癌で左半結腸切除術施行。20XX+2 年 7 月，右上背部 2×3cm 大の隆起した腫瘤を自覚し，前医にて悪性黒色腫と診断された。20XX+3 年 5 月に当院にて皮膚原発巣切除および腋窩リンパ節郭清術が施行され，同年 6 月より化学療法が開始された。20XX+3 年 10 月 CT にて肺，骨および肝臓に腫瘤像を認め，同年 11 月に乾性咳嗽と胸水貯留を認めたため，胸水一般検査が実施された。提出された胸水は黄色・微混濁様で，計算盤上に大型の由来不明細胞が散見された。ギムザ染色標本では，孤在性～小集塊状に出現する N/C 比の高い成熟リンパ球の 3-4 倍程度の細胞を多数認め，核分裂像や 2 核以上の多核細胞も散見された。これより病理部と顕微鏡によるディカッションおよび手術材料（右上背部皮膚）HE 染色標本における組織像所見の情報提供を受けた。後日，病理細胞診による細胞所見では，ギムザ染色標本と同様の異型細胞を認め，メラニン色素陰性であるものの，核内封入体を認めたことから，悪性黒色腫が強く疑われた。

【考察】低色素性メラノーマは色素欠乏により形態学的鑑別が困難であり，体腔液検体においては他がん細胞との鑑別を要する。本症例では，胸水一般検査における異型細胞の指摘を契機に，速やかに病理部と情報共有を行ったことで，適切な結果報告に結びついた。

【結語】胸水一般検査において悪性黒色腫細胞に遭遇する機会は少なく，また本症例のような典型的所見に乏しい場合においては，部門間連携による情報共有が重要であり，臨床検査技師の果たす役割は大きいと考えられた。

連絡先：058-230-6000